URS

U wordt binnenkort opgenomen via het dagziekenhuis Urologie voor een ureterorenoscopie (URS) ter behandeling van een niersteen.

Deze brochure wil u informeren over de geplande ingreep en wegwijs maken in het verloop van uw opname. Hebt u nog bijkomende vragen, dan kan u hiervoor uiteraard terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Wij wensen u alvast een spoedig herstel.

1. URS

U zal binnenkort een ureterorenoscopie ondergaan. Deze ingreep, doorgaans afgekort als URS, heeft tot doel nierstenen via een endoscopische benadering (kijkoperatie) te verwijderen. De ingreep wordt uitgevoerd wanneer een steen niet spontaan of door medicamenteuze therapie kon worden verholpen. Daarnaast kan de ingreep aangewezen zijn indien een steen vastzit in de urineleider en hierdoor aanleiding geeft tot pijnlijke nierkolieken, een urineweginfectie of een verminderde nierfunctie.

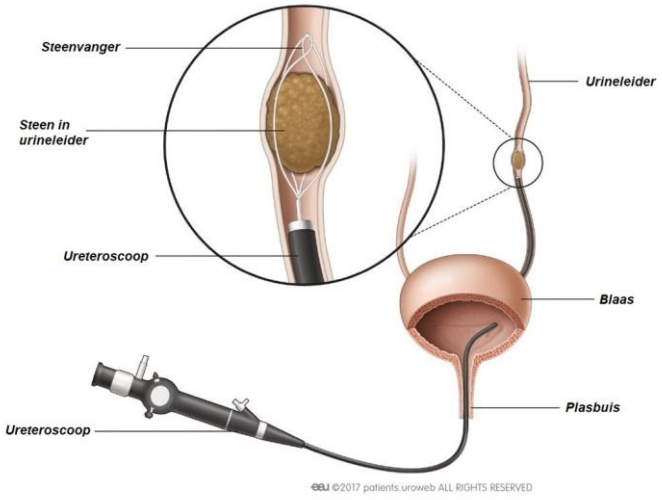
Een URS gebeurt onder algemene verdoving (algemene narcose).

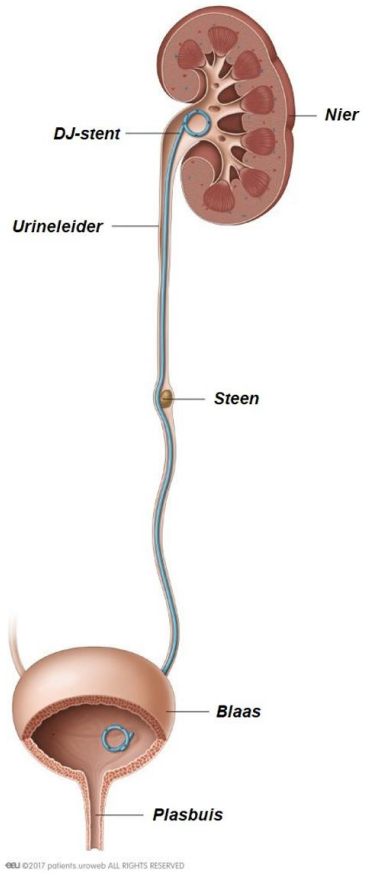
Tijdens de operatie brengt de Uroloog via uw plasbuis een dunne camera tot in de blaas en vervolgens de urineleider. De steen kan nadien door middel van een laser vergruisd worden of aan de hand van een tangetje verwijderd worden.

Soms is de urineleider te smal om de camera op te voeren en kan de steen bijgevolg niet bereikt en verwijderd worden. In dat geval wordt een buisje (dubbel J-stent, DJ-stent) nagelaten dat er voor zorgt dat de urineleider wordt opengehouden en de urine afvloei verzekerd wordt. Bijkomend zorgt het voor het ontspannen van de urineleider zodat enkele weken later tijdens een heringreep de urineleider vlot toegankelijk is.

Ook indien de ingreep vlot kon worden uitgevoerd, wordt er op het einde van de ingreep ingeschat of een DJ-stent dient nagelaten te worden. Deze stent zorgt ervoor dat de urineleider wordt opengehouden en er geen belemmering is in de afvloei van urine door steenfragmenten of zwelling van de urineleider. Of er al dan niet zo een stent wordt nagelaten, hangt af van hoe vlot de steen verwijderd kon worden en hoe de urineleider zich presenteert op het einde van de ingreep.

Het verwijderen van de stent gebeurt doorgaans 2 weken na de ingreep onder lokale verdoving op de controle consultatie. Indien een heringreep noodzakelijk is, blijft de stent behouden tot het volgende operatiemoment.





2. Complicaties

Elke operatie houdt bepaalde risico's in. Bij een ureterorenoscopie zijn de meest voorkomende:

- **Urineweginfectie:**
  Voor de ingreep wordt uw urine gecontroleerd op bacteriën. Indien nodig start u enkele dagen op voorhand met antibiotica. Tijdens de ingreep krijgt u bovendien preventief antibiotica toegediend via een infuus. Toch kan er na de ingreep een infectie optreden. Dit merkt u meestal zelf door het ontstaan van koorts, koude rillingen of een algemeen ziek gevoel.
- **Beschadiging van de urineleider:**
  Wanneer een steen langdurig vastzit of bij het veelvuldig inbrengen van instrumenten via de urineleider kan de wand van de urineleider beschadigd raken. Dit geneest meestal vanzelf, maar in zeldzame gevallen kan er op langere termijn een vernauwing (*strictuur*) ontstaan.
- **Bloed in de urine:**
  De aanwezigheid van bloed in de urine komt vaak voor na deze ingreep en verdwijnt meestal spontaan. Wanneer een DJ-stent geplaatst wordt, kan het bloedverlies aanhouden zolang de stent aanwezig is.
- **Pijnklachten:**
  Na de ingreep kunt u wat pijn of een branderig gevoel ervaren bij het plassen. Ook een zeurende pijn in de flank of blaasregio komt geregeld voor, zeker als er een DJ-stent geplaatst werd. Dit verdwijnt meestal geleidelijk en kan goed behandeld worden met pijnstillers zoals paracetamol.
- **Koorts of algemeen onwel gevoel:**
  Een beperkte temperatuursverhoging kort na de ingreep is niet ongewoon. Blijft de koorts aanhouden of stijgt ze boven 38°C, contacteer dan uw arts. Dit kan wijzen op een infectie die bijkomende behandeling vereist.
- **Nood aan heringreep:**
  In sommige gevallen kunnen kleine steendeeltjes achterblijven of kan de steen niet volledig verwijderd worden. Dan kan een tweede behandeling nodig zijn.

3. Voorbereiding

Preoperatieve consultatie (POC)

Sommige patiënten worden best voorgaand aan de ingreep gezien door de anesthesist (indien je > 70j bent, belangrijke medische voorgeschiedenis hebt, BMI > 35 hebt, of indien je 5 of meer geneesmiddelen neemt). Zij bekijken samen met u welke preoperatieve onderzoeken noodzakelijk zijn: bvb ECG of bloedafname. Of u bij de anesthesist dient langs te gaan, wordt besproken op de consultatie met uw behandelend Uroloog.

Urinestaal

Minstens 2-3 weken voor de ingreep dient een urinestaal via uw huisarts/ziekenhuis te worden binnengebracht om infectie na te gaan. In geval van infectie zullen wij u contacteren en antibiotica opstarten.

Medicatie

Bloedverdunners dienen meestal tijdelijk gestaakt te worden. Bespreek dit met uw behandelend Uroloog.

Antibiotica wordt voorafgaand aan de ingreep opgestart op advies van uw behandelend Uroloog in functie van een afwijkend urinestaal. Dit wordt telefonisch met u besproken, zorg dat wij steeds een geldig telefoonnummer van u in ons dossier hebben staan door dit via ons secretariaat door te geven.

Vergeet zeker niet uw thuismedicatie mee te brengen bij de opname. Bij voorkeur in de originele verpakking.

Uur van ingreep

Twee werkdagen voor de geplande operatiedatum wordt u telefonisch gecontacteerd om door te geven om welk uur u verwacht wordt in het ziekenhuis. Dit wordt afgestemd op het richt uur van de operatie maar is geen bevestiging van een bepaald uur, pin u dus niet per se vast op dit moment.

4. Opname op het dagziekenhuis

Voor deze ingreep wordt u meestal opgenomen via het chirurgisch dagziekenhuis. Als u anti-emboliekousen (= TED-kousen) hebt van een eerdere operatie, breng die dan mee. U mag 24u na de ingreep niet zelf rijden, voorzie dus vervoer.

De verpleegkundige of secretaresse van het dagziekenhuis zal u verwelkomen. De verpleegkundige stelt u nog enkele vragen om de zorg op u af te stemmen.

Omwille van de verdoving die u zal krijgen, mag u vanaf middernacht voor de ingreep niet meer eten, drinken of roken.

Ter voorbereiding op de ingreep vragen wij u aandacht te besteden aan een goede intieme hygiëne.

5. Moment van de ingreep

Op het ogenblik dat uw arts u naar de operatiezaal vraagt, zal de verpleegkundige u een operatiehemdje geven om aan te trekken. U trekt dan alle andere kledij uit, net zoals juwelen, kunstgebit, hoorapparaat of bril. De verpleegkundige brengt u met uw bed naar de bedhold (wachtzaal voor patiënten die geopereerd zullen worden).

Voordat u in slaap wordt gebracht, zal de Anesthesist u nog enkele vragen stellen. Het is mogelijk dat u uw Uroloog niet meer zal zien vlak voor u in slaap gaat, omdat hij pas binnenkomt als u al slaapt.

De ingreep duurt ongeveer 20 tot 90 minuten, maar is afhankelijk van het aantal stenen dat dient verwijderd te worden en de grootte van de stenen.

6. Na de ingreep

Opname post-anesthesie zorgafdeling (PAZA)

Na de ingreep gaat u naar de PAZA of ontwaakzaal. Hier wordt u tijdens het ontwaken uit de verdoving strikt opgevolgd door de verpleegkundigen en de Anesthesist. U zal verbonden zijn met een monitor waarop uw bloeddruk, pols en ademhaling gevolgd worden. De verpleegkundigen geven u ook de voorgeschreven pijnstilling.

Wanneer de Anesthesist beslist dat het veilig is om u terug naar het dagziekenhuis te brengen, zullen de verpleegkundigen u komen halen en terugbrengen. Het is best mogelijk dat u zich achteraf niet alles meer herinnert van het verblijf op de PAZA.

Terug op het dagziekenhuis

Wanneer u terug op het dagziekenhuis bent, zal u verder kort geobserveerd worden. U krijgt pijnstilling alsook iets om te eten en te drinken. Als u zich comfortabel voelt en goed kan urineren zal de Uroloog langskomen om uw ingreep en ontslag te bespreken.

7. Ontslag

De arts beslist wanneer u naar huis kan gaan. Voordat u naar huis gaat, krijgt u van de secretaresse of verpleegkundige een controleafspraak om terug te keren naar uw Uroloog.

8. Nazorg en verwachtingen thuis

Het herstel na een URS verloopt doorgaans vlot maar enkele ongemakken kunnen thuis wel nog voorkomen. Het kan zijn dat u gedurende enkele dagen lichte pijn of branderigheid ervaart bij het plassen. Eveneens kan er nog enkele dagen wat bloed in de urine zitten, hetgeen normaal is en spontaan verdwijnt.

Drink voldoende water (minstens 1.5 – 2 liter per dag) om de urinewegen te spoelen en neem de voorgeschreven pijnstilling en/of antibiotica zoals aangegeven.

Indien er tijdens de ingreep een DJ-stent werd geplaatst, kan u tijdelijk volgende symptomen ervaren: frequenter urineren, drukkend gevoel in blaas of flank, bloed in de urine, lichte pijn bij het plassen of blaaskrampen. Deze klachten verdwijnen na verwijderen van de stent. Indien deze klachten onvoldoende te controleren zijn met klassieke pijnstilling, kan in overleg met uw behandelend Uroloog alternatieve medicatie worden opgestart, namelijk anticholinergica (bvb solifenacine of oxybutynine) of een β-3-adrenoceptor-agonist (bvb vibegron of mirabegron).

9. Alarmtekens

Alertheid voor eventuele complicaties is belangrijk. In volgende situaties raden wij aan uw Uroloog te contacteren of zich te melden via Spoedgevallen:

- Koorts boven de 38.5°C of koude rillingen
- Ernstige onderbuikspijn die met klassieke pijnstilling of de voorgeschreven medicatie niet onder controle geraakt
- Uitgesproken bloed in de urine met bloedklonters
- Onmogelijkheid te urineren of erg pijnlijke gevoel bij het plassen.

⇨ Indien uw twijfelt over uw symptomen kan u altijd contact opnemen met de dienst Urologie.

10. Checklist: wat breng ik mee bij een opname?

- Thuismedicatie, bij voorkeur in de originele verpakking. Inclusief eventuele antibiotica of bloedverdunners.
- TED-kousen zo u dit heeft
- GSM en oplader
- Eventuele vragenlijsten of papieren die u nog waren gevraagd in te vullen
- Verzekeringspapieren die dienen getekend te worden door de arts

11. Vragen? Noteer ze hieronder.

1. Contact

Hospitalisatieafdeling Urologie
Tel. 09 332 27 61

Polikliniek Urologie
Tel. 09 332 22 76

Link naar ingreep:

https://youtu.be/oU_GUAWz52w